

39 - DÉLIVRANCE NORMALE ET PATHOLOGIQUE - Pr. AIT BENKADDOUR

(0:06 - 0:38)

Ceci est un cours destiné aux étudiants de cinquième année des études médicales dans le cadre du module de gynécologie obstétrique de la Faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech. Il s'agit du cours sur la délivrance normale et pathologique. Ce cours revêt un intérêt important du fait de la gravité de certaines complications, de l'importance de cette période et de cet événement qui est la délivrance qui fait suite immédiatement à l'accouchement.

(0:39 - 1:21)

Il est défini comme étant l'ensemble des phénomènes qui font suite à l'accouchement aboutissant au décollement du placenta et de ses membranes ainsi qu'à son expulsion hors de la cavité. Sur le plan chronologique, il est défini comme étant les deux heures suivant l'expulsion fœtale et dans la littérature anglophone, on considère et il est nommé comme étant la troisième ou le troisième stade du travail et qui va comporter trois étapes successives sur le plan physiologique qu'on va voir et étudier. La première étape, c'est le décollement du placenta et les membranes.

(1:21 - 6:08)

La deuxième, c'est la migration du placenta dans le segment inférieur puis dans le vagin et la troisième, c'est l'expulsion du placenta et des membranes hors de la vulve. Comme on a dit, ce chapitre revêt une importance capitale du fait de la gravité de certaines complications et on considère que cette période de délivrance est la période la plus dangereuse pour la mère vu le risque d'hémorragie et la mortalité et la morbidité liées à ce risque-là, comme on va le voir, d'où l'intérêt de la vigilance dans la prise en charge et la surveillance de cette période-là du fait de l'augmentation des complications maternelles et surtout de l'hémorragie qui constitue la première cause de mortalité maternelle partout dans le monde, y compris dans notre pays. Donc, avant d'aborder le côté clinique, il est utile de rappeler quelques éléments anatomiques et qui vont nous permettre de comprendre certaines particularités de cette période, d'abord la vascularisation de l'utérus, la structure et la structure aussi de la caduque, c'est-à-dire de la partie la plus profonde du placenta et qui est la partie qui conditionne son insertion.

Donc, comme vous le savez déjà très bien, la vascularisation de l'utérus est une vascularisation très riche et qui dépend de plusieurs artères, quoique l'artère principale est l'artère utérine qui est une branche de l'artère épigastrique, cependant il y a aussi une anastomose très riche avec les branches de l'artère vaginale qui est aussi une branche de l'artère épigastrique et de l'artère ovarique qui vient directement de la honte, comme vous le voyez sur ce schéma, et donc un réseau anastomotique très important entre le côté droit, le côté gauche et entre les trois composantes de cette vascularisation. De ce fait-là, toute hémorragie utérine, surtout dans la

période de la grossesse, est gravissime vu la richesse de cette vascularisation initialement et son développement très important au cours de la grossesse. Deuxième chose à savoir, c'est surtout l'insertion du placenta et l'anatomie du placenta qui est faite sous forme de plusieurs cotylédons qui constituent l'unité fonctionnelle et ces cotylédons contiennent la chambre intervillieuse dans laquelle baignent les structures vasculaires fœtales et cette chambre intervillieuse est irriguée par des artères, ce qu'on appelle les artères spirales qui proviennent des branches de l'artère utérine.

Donc c'est une vascularisation très importante avec des vaisseaux qui sont baignants et qui vont se déverser dans ces chambres-là. Deuxième chose qu'on peut voir sur ce schéma-là, c'est l'insertion placentaire qui se fait au niveau de l'ancien endomètre qui a constitué la caduque et qui est séparée en deux parties, la caduque spongieuse qui va constituer la partie qui va rester au niveau de l'utérus et la partie compacte qui part avec le placenta et donc l'existence d'un plan de clivage entre ces deux couches-là est très important pour la délivrance et pour le décollement du placenta comme on va le voir tout à l'heure. Donc on revoit la même chose sur ce schéma-là, ce que je viens de dire, ça en haut c'est la face fœtale du placenta et en bas c'est la face maternelle, vous voyez la vascularisation fœtale qui baigne dans les chambres intervillieuses et vous voyez les crampons placentaires qui sont centrés par les vaisseaux spiralés et vous voyez à la base l'hémiomètre puis la couche basale résiduelle puis la couche spongieuse et la couche compacte et donc l'existence d'un plan de clivage entre la couche spongieuse et la couche compacte est un impératif anatomique pour un bon déroulement de la délivrance et du décollement.

(6:09 - 10:39)

Donc sur le plan physiologique, les phases de la délivrance peuvent être subdivisées en plusieurs étapes, la première étape est celle qui va faire suivre immédiatement après l'expulsion fœtale, on va assister à une rétraction utérine de façon physiologique et qui va entraîner un enclavement, c'est-à-dire des pressions sur la partie latérale du placenta, donc ceci est secondaire à une rétraction par les fibres élastiques contenues dans l'hémiomètre, donc c'est une rétraction passive puis va suivre une rétraction par des contractions utérines qui vont reprendre 5 à 10 minutes après l'expulsion et la création d'un hématome rétro-placentaire qui est physiologique, puis par la suite, la phase suivante c'est la phase de migration et d'expulsion du placenta, puis la phase de rétraction utérine et des moustaches, donc le décollement, comme on vient de le dire, après le dégagement, l'utérus va subir une rétraction élastique passive sur toute la partie utérine sauf au niveau de la partie de l'insertion, ce qui va exercer une pression sur le pourtour du placenta et un tassement physiologique du placenta, ce qui va créer un début de décollement, une déchirure de certains vaisseaux utéro-placentaires qui vont créer cet hématome rétro-placentaire physiologique, donc au cours de cette partie on va assister à une diminution de la hauteur utérine et dans le même temps l'intensité des contractions va diminuer, mais il n'est pas ressenti par la patiente ni par la coucheuse. Ensuite la phase de décollement qui va être débutée après 10 à 15 minutes, donc on va voir la réapparition des contractions utérines

qui vont devenir cliniquement perceptibles, ce renforcement précédé quelques minutes par l'augmentation des concentrations d'ocytocine, donc après l'expulsion et donc lors de la distension vaginale, il y aura un réflexe qu'on appelle le réflexe de Ferguson qui va stimuler le post-hypophyse et qui va synthétiser l'ocytocine qui va entraîner cette augmentation des contractions utérines. Donc le placenta qui est enchâtonné physiologiquement et dont le porto est cerné par un anneau musculaire va subir des pressions concentrées qui vont tendre à le faire bomber dans la cavité et créer ainsi des décollements par endroits qui vont aboutir rapidement à un hématome rétro-placentaire.

Donc comme vous le voyez sur le schéma en haut, donc la création de cet hématome et qui va entraîner l'inversion du placenta et la création de cet hématome et donc le décollement qui va se compléter au fur et à mesure jusqu'à intéresser toute la surface du placenta et à partir de ce moment là, la phase de décollement est accomplie et on va assister après à la phase d'expulsion. Donc le clivage, comme on l'a dit au tout début, nécessite l'existence d'un plan de clivage entre la caduque spongieuse et la caduque compacte et qui grâce à la rétraction physiologique de l'utérus et les contractions utérines va pouvoir se détacher et donc constitution de l'hématome comme on a dit par clivage et ouverture des sinus veineux. Ça c'est ce qu'on vient de dire par rapport à ce décollement et qui va libérer la zone d'insertion placentaire permettant au myomètre situé en regard de parachever sa rétraction élastique passive puis active sous l'effet des contractions.

(10:39 - 29:10)

Donc une fois cette phase de décollement terminée, on va assister à la phase de migration du délivre qui va se faire sous l'influence des contractions utérines réflexes et qui va se faire selon deux modes différents en fonction du type d'insertion du placenta, on appelle le mode de Baudelot qui est de loin le plus fréquent puisqu'il considère les placentas normalement, il est donc il est correspondant aux placentas normalement insérées et le mode 2 d'Encant c'est le mode qui est spécifique aux placentas bas insérées. Donc le premier mode qui est le plus fréquent, après le décollement du placenta et la constitution de l'hématome rétro-placentaire physiologique, la pression qui se fait par le poids du placenta, par les contractions utérines, par l'hématome qui est en train de pousser le fond du placenta, ce placenta va s'inverser et être extériorisé et expulsé par la face fœtale comme on le voit sur ce schéma là. Donc cette migration va se faire au fur et à mesure que les membranes elles aussi vont se décoller au fur et à mesure et le placenta va être extériorisé de l'utérus et expulsé hors de l'utérus sous l'effet du poids de la contraction et aussi parfois de la traction du cordon exercée par la coucheur.

Donc à la fin, sous l'effet des contractions utérines, le placenta va quitter le segment inférieur et va être propulsé vers le vagin. A ce moment là le fond utérin va redescendre et il va former au dessus de la symphyse pubienne ce qu'on appelle le globe de sécurité, l'élément de sécurité qui va témoigner d'une bonne contracture utérine. Le mode de Duncan c'est, il est plutôt révélateur des placentas bas insérées donc le décollement et l'expulsion va se faire par glissement puisque

le décollement se fait sous l'effet des contractions et de l'hématome et donc puisque le placenta est latéral, il n'est pas fendique, il n'y aura pas d'inversion mais il y aura plutôt un glissement et comme on peut le comprendre la migration va se faire à ce niveau là et puis l'extériorisation va se faire par la face maternelle et comme on peut aussi le comprendre la traction exercée sur la partie contralatérale des membranes va être importante et de ce fait là le risque de déchirure des membranes lors de l'expulsion et ainsi de rétention membrane est plus élevé dans ce mode là.

A la fin donc l'expulsion hors du vagin peut se faire spontanément sans l'aide d'une pierre d'une tierce personne comme elle peut se faire par des manœuvres aidant l'expulsion soit de compression du fond utérin soit de traction douce sur le cordon. En principe la présence du placenta dans le vagin au contact du plancher périnéal va stimuler les efforts expulsifs de la patiente qui va achever l'expulsion hors du vagin. A la fin de l'expulsion hors du vagin, la fin phénomène très important et qui constitue la sécurité de la patiente c'est l'hémostase c'est à dire l'arrêt de l'hémorragie comme on l'a vu sur les schémas au début les vaisseaux utéro-placentaires et les vaisseaux spirale et les artérioles spirale sont béantes ouvertes sur le placenta sur les chambres intervasculaires après le décollement de ce placenta ces vaisseaux si elles restent béantes vont entraîner une hémorragie très importante et de ce fait là leur hémostase est assurée par deux principaux mécanismes le mécanisme le plus important c'est ce qu'on appelle les ligatures vivantes de pinard il s'agit de l'obturation de ces vaisseaux là par les fibres musculaires qui les entourent suite à la contraction de l'utérus et donc de ce fait là l'élément principal pour l'hémostase immédiate après un accouchement c'est la rétraction et la contraction de l'utérus comme on l'a vu qu'on va appeler le globe de sécurité donc c'est le garant de l'hémostase initial puis par la suite suite à l'activation du processus de l'hémostase pour lequel la patiente était bien préparée par l'augmentation de la synthèse des facteurs de coagulation au cours de la grossesse on va assister à une hémostase définitive par la constitution du caillot sanguin qui va obturer tous ces vaisseaux sous l'effet comme on a dit de l'activation de l'hémostase et qui est stimulé aussi par la richesse placentaire en thromboplastine qui sont des substances pro-coagulantes qui vont être libérées lors du décollement donc en résumé le bon déroulement de la délivrance nécessite un muscle utérin apte à remplir sa fonction contractile et rétractile deuxièmement une caduque se clivant à la limite de ces deux couches spongieuses et compactes troisièmement un placenta normal dont sa forme ses dimensions et aussi son insertion quatrièmement une coagulation efficace et cinquièmement une attitude médicale qui va respecter la physiologie parce que une intervention non appropriée peut conduire à des anomalies de la délivrance et augmenter ainsi le risque de complications.

Toute anomalie portant sur ce l'un de ces facteurs peut être responsable de complications. Donc après avoir vu ces éléments de la physiologie de la délivrance on va passer pour l'étude clinique et on va commencer par connaître d'abord les types de délivrance donc il y a la délivrance normale spontanée et qui correspond à l'expulsion du placenta qui se fait sous le simple effet de la gravité des contractions musculaires réflexes du périnée et des efforts maternels donc il n'y a aucune intervention d'une tierce personne. La délivrance normale naturelle donc la délivrance est

faite et le délivre est extrait par des manœuvres par la sage-femme ou la coucheur par des manœuvres très simples donc légère tension du cordon refoulement de l'utérus vers le haut et qui va achever le décollement et l'expulsion du placenta.

Troisièmement la délivrance dirigée où le médecin ou la sage-femme vont intervenir pour un petit peu intensifier les contractions utérines par une injection d'ocytocine immédiatement après l'accouchement. La délivrance artificielle c'est une délivrance avec intervention complète de la coucheur où on va mettre la main à l'intérieur de l'utérus pour pouvoir décoller et extraire le placenta. Donc sur le plan clinique ces trois phases qu'on a vu en physiologie on va pouvoir les observer donc la première phase immédiatement après l'accouchement donc c'est l'arrêt des contractions pendant 10-15 minutes jusqu'à 30 minutes si c'est supérieur à 30 minutes à ce moment là on peut avoir une rétention placentaire l'utérus est à ce moment là dur et il est sous l'embylique et on reconnaît le non décollement du placenta par la manoeuvre qui va consister à refouler l'utérus vers le haut et regarder est-ce que ces mouvements sont transmis au cordon ou non.

Donc s'ils sont transmis ça veut dire que le placenta fait encore corps avec l'utérus et donc il est mobilisé avec lui et ça se traduit par la mobilisation du cordon. Si il y a un détachement c'est à dire on refoule l'utérus vers le haut et on voit que le cordon n'ascensionne pas ça veut dire que le placenta est détaché et il est décollé à ce moment là on peut l'aider à être extériorisé sans grand risque d'entraîner une inversion ou une déchirure du placenta ou du démembrane. La phase de décollement donc on va assister à la réapparition des contractions utérines l'utérus à ce moment là va être au dessus de l'embylique puisque le placenta descend il se remplit encore par l'hématome rétro placentaire physiologique et il va remonter va devenir plus grand de volume.

Il n'y a plus de transmission des mouvements de la main sur l'utérus vers le cordon donc c'est le diagnostic du décollement et on va assister à une petite hémorragie vulvaire. Troisièmement la phase d'expulsion où l'utérus va redescendre sous l'embylique puisque à ce moment là il est vite et contracté ça veut dire qu'il est dur et petit de taille et de situation sous-embylicale. C'est ce qu'on appelle le globe de sécurité parfois envie de spontanée d'expulser si la patiente a le placenta au niveau du vagin et à ce moment là donc on va le plus souvent aider l'extériorisation complète du placenta soit par traction sur le cordon ou pression sur l'utérus.

Donc durant cette phase la conduite à tenir est très importante parce que c'est elle qui va permettre d'abord de respecter la physiologie de faire diminuer le risque de complications mais surtout surtout de dépister ces complications afin de pouvoir les traiter très rapidement et d'améliorer le pronostic. Donc cette surveillance se fait en salle d'accouchement et c'est quelque chose d'universel, d'obligatoire de garder toujours la femme qui a accouché sur le site d'accouchement c'est à dire à la salle d'accouchement durant au moins deux heures suivant la délivrance. C'est quelque chose d'obligatoire et de fondamental.

Au cours de ces deux heures on va examiner la patiente sur le plan général et sur le plan

obstétrical au moins toutes les 30 minutes si les choses semblent être physiologiques, un peu plus rapprochées s'il y a des éléments en faveur de complications. Donc on va prendre les constantes générales pour la tension artérielle, on va voir l'existence d'une décoloration des conjonctives de cyanose, de sueur témoignant d'un problème hémodynamique. Sur le plan obstétrical on va obligatoirement examiner le globe de sécurité pour voir est-ce qu'il est bien rétracté et il est sous-ombilical et évaluer de manière visuelle et quantitative le saignement extériorisé, saignement vulvaire.

Donc les critères de décollement du placenta au cours de la délivrance on l'a déjà vu, donc la position du phant, l'hémorragie physiologique, le glissement du cordon, les manœuvres de mobilisation qu'on a vu. Donc ce schéma là montre ce qu'on vient de dire, c'est lorsque on met de la pression sur le fond utérin, si le placenta est toujours solidaire à l'utérus, le cordon va remonter et l'inverse si il est déjà détaché. Comme on a déjà vu, l'extraction du placenta peut se faire de manière, soit une traction je dis toujours douce et continue, contrôlée sur le cordon qui va permettre d'extérioriser et qu'il ne faut jamais exercer de manière importante ou par saccade et surtout lorsque le placenta n'est pas encore décollé parce qu'on peut entraîner une déchirure des membranes ou une inversion utérine.

Deuxième méthode c'est de faire et d'aider l'expulsion du placenta en mettant une main sur le fond utérin et de pousser vers le bas afin d'aider l'expulsion du placenta. Chose qu'on voit ici sur ces images là. La délivrance dirigée donc c'est une méthode qu'on utilise pratiquement systématiquement et qui est recommandée afin de réduire le temps de la délivrance, du risque d'hémorragie aussi.

Donc c'est une recommandation de l'Organisation Mondiale de la Santé d'administrer 5 à 10 unités d'ocytocine, soit par voie intramusculaire soit le plus souvent par voie intraveineuse puisque les patients en général qui accouchent ont déjà une voie veineuse. Donc une fois après l'expulsion de la deuxième épaule du fœtus, on administre 5 à 10 unités d'ocytocine et qui va accélérer le processus de décollement du placenta suite à l'expulsion fœtale et de ce fait réduire le risque d'hémorragie. La délivrance artificielle est une délivrance qui est faite chirurgicalement, c'est à dire par intervention du médecin ou de la sage-femme.

Elle a deux principales indications, soit lorsqu'on assiste à une hémorragie de la délivrance, soit lorsque le placenta ne se décolle pas spontanément au bout de 30 minutes, ce qu'on appelle la rétention placentaire. Donc ça se fait dans des conditions chirurgicales, c'est à dire badigeonnage du vagin et de la vulve, port de gants, lavage des mains et anesthésie le plus souvent, sauf si on est face à une extrême urgence. Donc on va suivre le trajet du cordon jusqu'à repérer le placenta et on va voir le portoro du placenta, on va décoller sur un point, puis mettre la main par entre le placenta et l'utérus et par le bord cubital de la main, faire le pourtour du placenta et le décoller complètement avant de l'empaumer et de pouvoir l'extérioriser comme on voit ici sur ces schémas là.

Donc vous voyez, introduction, on va céder par la main abdominale qui va nous permettre de contrôler l'utérus, la main vaginale s'introduit entre le placenta et l'utérus et on va le décoller, l'empaumer et l'extérioriser. Après avoir extériorisé le placenta ou après son expulsion, elle se fait spontanément, il est obligatoire et systématique d'examiner le placenta et les membranes, ce qu'on appelle le délivre, afin de pouvoir vérifier son intégrité parce qu'on peut avoir une rétention partielle après déchirure du placenta et de vérifier le cordon ombilical et ce qu'il s'agit d'un cordon normal avec deux artères et une veine puisque si on n'a pas cette disposition vasculaire, le risque d'avoir des malformations néonatales est plus élevé donc on va attirer l'attention du pédiatre afin d'examiner le nouveau-né. On va mesurer le petit côté des membranes puisque si ce petit côté est inférieur à 10 cm, ça devrait attirer notre attention sur le fait que ça peut être un placenta prévia et on sait très bien que lors du placenta prévia, le risque d'hémorragie du postpartum est plus élevé et de ce fait cette patiente doit avoir une surveillance plus stricte.

On peut peser aussi le placenta et s'il y a un contexte infectieux, on va faire des prélèvements bactériologiques. L'existence heureusement rare dans notre contexte de micro-abcès au niveau du placenta est très évocatrice d'une listeriose. Heureusement que cette infection est rare dans notre contexte.

(29:15 - 42:05)

Donc après avoir vu ces éléments physiologiques et cliniques de la délivrance normale, on va s'intéresser aux complications de la délivrance qui sont au nombre de 4 complications la rétention placentaire, l'hémorragie de la délivrance qui est de loin la situation la plus grave et aussi la plus fréquente, l'inversion utérine. On va d'abord étudier la rétention placentaire qui est définie comme étant l'absence de délivrance au-delà de 30 minutes après l'expulsion foetale. Cette rétention peut être complète comme elle peut être partielle.

La rétention placentaire est une situation assez fréquente elle peut être causée par une anomalie de la contraction utérine et c'est le cas le plus souvent, soit par une absence de contraction utérine et donc absence de décollement placentaire et absence d'expulsion, c'est le cas de l'inertie utérine qui peut être causée soit par un travail très prolongé et un épuisement musculaire de l'utérus, soit par une surdistension utérine lors des grossesses multiples de l'hydramnios et de la macrosomie ou par une pathologie modifiant la contractilité comme les fibromes et les malformations ou parfois par des causes iatrogènes comme l'utilisation de produits anesthésiques myorrelaxants comme le fluotan, l'utilisation des tocolithiques ou bien parfois l'arrêt intempestif des ocytocyes utilisés en fin de travail. A l'inverse, une hypertonie utérine, c'est à dire des contractions utérines très intenses, peuvent aussi être la cause d'une rétention placentaire parce qu'ils vont aboutir à ce qu'on appelle un non-châtonnement placentaire ou à une incarceration. La différence entre les deux c'est que l'enchâtonnement c'est une hypertonie localisée sur des parties et qui va enclaver le placenta dans une partie de l'utérus alors que l'incarcération est une hypertonie au niveau du col ou bien au niveau du segment inférieur qui va

un petit peu incarcérer ou empêcher le placenta de s'extérioriser alors que probablement il est déjà décollé.

On peut aussi avoir une rétention placentaire à cause d'un défaut de décollement suite ou secondaire à des anomalies d'insertion comme par exemple les placentas Acreta ou le placenta lors de son implantation et de placentation, l'invasion du trophoblaste a dépassé les limites de l'endomètre et de la caduque et donc elle a envahi le myomètre et de ce fait là le décollement entre la couche spongieuse et la couche compacte est impossible et de ce fait là le placenta ne peut pas se décoller. Les placentas Acreta peuvent être causées par des anomalies de la paroi utérine sur laquelle va s'insérer le placenta et ce plus souvent secondaire à un traumatisme utérin soit par curtage, infection, utérus cicatriciel, chirurgie par exemple soit de césarienne ou de fibromes et qui va altérer la paroi utérine et de ce fait là altérer la qualité de la placentation. D'autres causes aussi de rétention c'est des problèmes d'insertion morphologique lorsqu'on a des cotylédons accessoires ça veut dire que vous avez la masse placentaire qui est à côté et de l'autre côté des cotylédons qui sont séparés du placenta et lors du décollement et de l'expulsion du placenta elle se fait normalement mais il reste un cotylédon à l'intérieur qui va constituer une rétention placentaire partielle avec le risque de complications.

Lorsqu'on va avoir une localisation par exemple bas insérée ce qu'on appelle le placenta prévia, le placenta étant inséré sur le segment inférieur et on sait que sur le plan anatomique le segment inférieur n'est pas très riche en fibres musculaires mais plutôt en fibres élastiques et de ce fait là le décollement du placenta se fait moins bien que lorsque le placenta est d'insertion fœtale et ça peut être la cause d'une rétention ou d'une hémorragie. Parfois cette rétention est la cause d'une mauvaise intervention médicale qui est la délivrance dirigée parfois trop tardive donc on n'a pas fait la délivrance dirigée au bon moment et on l'a fait plus tardivement et de ce fait là on va juste augmenter les contractions utérines et entraîner un moment qui n'est pas favorable au décollement et donc entraîner l'incarcération de l'utérus parfois la traction sur le cordon ou l'expression avant le décollement placentaire peut entraîner une déchirure du placenta et donc on va extérioriser juste une partie et entraîner une rétention partielle. Donc comme on le voit sur ce schéma là, l'endomètre avec le plan de décollement à ce niveau là entre la couche compacte et la couche spongieuse, le placenta s'il envahit le myomètre, une partie du myomètre, la partie superficielle, on l'appelle la crêta, lorsqu'il envahit une grande partie du myomètre, il est en crêta et lorsqu'il dépasse l'utérus et parfois il va aller envahir aussi la vessie, on l'appelle percrêta.

Ce diagnostic peut être fait ou découvert lors de la délivrance mais de plus en plus on le suspecte au cours de la surveillance de la grossesse par l'échographie, surtout chez les patientes ayant un utérus cicatriciel avec un placenta qui s'insère sur la paroi antérieure, c'est-à-dire sur la cicatrice de césarienne. Ces patientes avec ces deux critères là, on fait très attention au cours du troisième trimestre et on fait l'échographie à la recherche d'images en faveur du placenta à crêta, notamment la disparition du mur de sécurité et la vascularisation parfois qui est anarchique à ce niveau là et dans les cas difficiles on peut s'aider de l'IRM qui a une valeur plus

importante que l'échographie pour le diagnostic positif des placentas à crêta. Maintenant on a fait le diagnostic de la rétention, donc 30 minutes après il n'y a pas d'expulsion, on vérifie que le placenta n'est pas décollé et on retrouve qu'il n'est pas décollé.

Quelle est la conduite à tenir? C'est systématiquement faire ce qu'on appelle une délivrance artificielle sous anesthésie. On va faire un lavage chirurgical des mains, porter des gants spécifiques pour la délivrance artificielle, badigeonner le vagin, badigeonner la vulve, introduire la main et réaliser la délivrance. Il ne faut pas omettre d'administrer une dose d'antibio-prophylaxie pour réduire le risque d'infection puisque c'est un geste invasif ondo-utérin qui va augmenter le risque d'infection utérine du post-partum.

Et une fois qu'on a fait décoller le placenta, on va l'extérioriser et on va renforcer la contraction musculaire pour assurer l'hémostase par une perfusion d'ocytocine immédiatement après cette délivrance artificielle. Si cette rétention est hémorragique on fera aussi en parallèle une réanimation de la patiente avec un bilan comme on va le voir tout à l'heure. Deuxième complication c'est l'inversion utérine qui heureusement est une complication rare et qui va correspondre à l'invagination du fond utérin en bas de gants jusqu'à parfois une extériorisation du fond de l'utérus vers l'extérieur en dehors de la vulve.

Donc c'est une complication que malgré qu'elle soit exceptionnelle peut engager le pronostic vital maternel et donc d'où l'intérêt d'un diagnostic précoce et d'un traitement spécifique et précoce. Donc on va y penser devant toute hémorragie et l'examen clinique en général est suffisant pour poser le diagnostic positif et immédiatement entreprendre le traitement. Donc l'inversion utérine peut être causée par plusieurs choses notamment par une hypotonie de l'utérus donc un utérus très flasque de grande multipart ou en cas de surdistension ou de travail prolongé et de ce fait là l'extériorisation du placenta va attirer avec elle le fond de l'utérus vu que l'utérus est pas du tout contractile et donc il va s'inverser très facilement.

Deuxième cause qui peut entraîner l'inversion c'est l'adhérence anormale du placenta notamment dans le cadre d'un placenta à crêta et donc l'extériorisation du placenta va entraîner avec elle le fond de l'utérus. Troisième cause c'est la traction intempestive ou l'expression du fond utérin de façon inadéquate qui va faire extérioriser le fond de l'utérus. Comment va se manifester l'inversion utérine? C'est d'abord des douleurs intenses puisque l'inversion de l'utérus va se faire avec le fond de la cavité qui peut être totalement extériorisé comme on le voit sur ce schéma là et donc le pourtour vaginal et le col de l'utérus va exercer un effet de garou sur l'utérus et donc ce qui va entraîner une ischémie qui va entraîner des douleurs très intenses pouvant donner même un état de choc.

Donc le diagnostic est souvent assez facile soit c'est une inversion qui n'est pas extériorisée et dans ce cas là c'est la révision utérine qui va faire le diagnostic soit c'est au niveau du col c'est le toucher vaginal soit c'est totalement extériorisé comme on le voit sur cette photo là et le diagnostic est évident par l'inspection. Donc il existe plusieurs formes anatomiques des formes

où comme j'ai dit le fond de l'utérus est inversé mais qui reste dans la cavité utérine. Il peut aussi affleurer la vulve comme elle peut être extériorisée comme l'image qu'on vient de voir.

Quelle est la conduite à tenir devant une inversion utérine? Donc il s'agit d'une urgence médico-obstétrique. Il faut réanimer les patients, prendre une voie veineuse, administrer des antalgiques, des antibiotiques. S'il y a un état de choc réanimer l'état de choc puis mettre une anesthésie et essayer de réduire l'utérus le plus souvent par taxis c'est à dire on va prendre le fond utérin et essayer de le réintégrer dans la cavité utérine puisque si ce traitement n'est pas fait on risque d'avoir d'abord une infection et deuxièmement comme j'ai dit par l'effet de garrot exercé par le col sur la vascularisation on peut avoir une ischémie et une nécrose voire une gangrène totale de l'utérus avec des complications infectieuses parfois très graves.

(42:07 - 1:07:32)

Le plus souvent cette réduction se fait juste à la main sans aucun problème mais dans certaines situations l'effet du garrot du col est tellement important que le fond utérin est irréductible et dans ce cas là on va devoir le faire chirurgicalement sous anesthésie générale on va faire l'aparotomie et on va ainsi prendre le fond de l'utérus par des pinces le réduire parfois on a besoin même de faire une hystérotomie c'est à dire ouvrir la cavité de l'utérus afin de pouvoir le réintroduire donc on a vu les deux complications c'est à dire la rétention placentaire et l'inversion utérine on passe maintenant à la complication la plus importante et la plus grave et qui constitue tout l'intérêt de ce cours d'aujourd'hui donc il s'agit de l'hémorragie de la délivrance donc l'hémorragie de la délivrance est définie comme le stipule les dernières recommandations du collège américain donc puisque la définition a été révisée un petit peu à la haute avant on parlait d'une hémorragie de la délivrance si le saignement extériorisé supérieur à 500 ml actuellement depuis 2017 cette définition est revue à la hausse c'est à dire qu'on va parler d'une hémorragie de la délivrance ou d'une hémorragie plutôt du postpartum immédiat lorsqu'on va avoir un saignement extériorisé supérieur ou égal à un litre de sang ou bien s'il y a une perte de sang mais qui est associé à des signes de retentissement hémodynamique notamment une tachycardie ou bien une hypotension témoignant d'une hypovolémie et ceci bien sûr durant les 24 heures suivant l'accouchement donc les facteurs de risque d'avoir une hémorragie de la délivrance ce sont tous les facteurs de risque qui vont entraver le déroulement d'une bande de délivrance comme on l'a vu tout à l'heure et c'est surtout les facteurs qui vont être limitatifs ou qui vont influencer la qualité de la contractualité utérine notamment la multiparité la surdistention utérine soit par la macrosomie l'hydramnios ou la grossesse gemellaire, l'épuisement du muscle utérin par un travail très prolongé et l'utilisation intense des ocytociques, les défauts de décollement du placenta secondaire soit à un placenta prévia ou un placenta accreta, la césarienne aussi, les éléments qui vont augmenter le risque d'avoir des déchirures et des lésions traumatiques de l'utérus ou du col ou du vagin notamment l'extraction instrumentale, les facteurs qui peuvent modifier l'hémostase et la coagulation notamment donc les coagulopathies qu'elles soient acquises au congénital et surtout la prééclampsie. Les causes de l'hémorragie peuvent être soit un défaut de contractualité utérine ce

qu'on appelle l'inertie utérine qui est la cause de loin la plus fréquente, c'est la première cause d'hémorragie du postpartum immédiat ou bien secondaire à une rétention placentaire surtout partielle qui est beaucoup plus hémorragique que la rétention totale, des troubles de la coagulation qui peuvent être secondaires à une mort fatale utéro, à un hématome rétro-placentaire, un choc septique ou un choc hémorragique, l'insertion basse du placenta, ce qu'on appelle le placenta prévia même après délivrance normale c'est à dire expulsion du placenta, le risque est plus élevé d'avoir une hémorragie vu que la valeur contractile du segment inférieur est moins importante que le reste du corps utérin, l'inversion utérine et les lésions traumatiques que ce soit au niveau de l'utérus qu'on appelle la rupture utérine ou au niveau du défilé cervico-vaginal, c'est les déchirures cervico-vaginales. Donc il faut toujours raisonner de manière très simple face à une hémorragie, est-ce que ce saignement provient comme on le voit sur ce schéma de l'OMS, est-ce que le saignement provient de l'utérus, du site placentaire et ce qui définit de manière, ce qu'on appelle l'hémorragie de la délivrance ou bien il provient du reste de l'utérus, ça peut être soit par une inertie utérine, des fausses contractions, soit par une lésion traumatique, soit par un placenta accreta, soit ce saignement peut provenir aussi du col, c'est le plus souvent les déchirures secondaires à un traumatisme, soit par le mobile foetal lui-même, la tête foetale qui peut déchirer le col lorsque l'accouchement se fait à dilatation incomplète ou par des manœuvres notamment par des extractions instrumentales.

Donc le saignement peut aussi provenir du vagin et c'est essentiellement les déchirures vaginales secondaires là aussi soit au mobile foetal ou à des instruments utilisés, parfois c'est au niveau du périnée, ça peut être l'épiziéotomie qui a été étendue lors de l'accouchement ou par un instrument notamment le forceps ou la ventouse ou bien par une déchirure même si on n'a pas fait d'épiziéotomie donc l'expulsion foetale a entraîné une déchirure et donc le saignement peut provenir de ça, de cette région. Il faut juste attirer l'attention sur le fait qu'on peut avoir une multitude de causes et ça c'est un élément très important puisqu'on peut avoir une inertie utérine associée à une déchirure vaginale et ceci peut s'expliquer par plusieurs mécanismes, le plus simple est à titre d'exemple l'accouchement d'un macrosome qui va donner déjà une surdistension utérine, deuxièmement un travail le plus souvent prolongé avec un épuisement utérin et un accouchement aussi traumatique c'est à dire lors de l'expulsion il peut entraîner une déchirure soit cervicale ou vaginale ou périnéale et de ce fait là dans ces situations là on peut avoir l'association d'une inertie utérine associée à une déchirure cervicale et une déchirure périnéale, d'où l'intérêt de toujours compléter la recherche étiologique même si on a trouvé une cause il faut rechercher est-ce qu'il n'y a pas d'autres causes associées. Comme on a dit la cause la plus fréquente est l'inertie utérine qui va compliquer 2 à 5% des accouchements et il va entraîner au tout début un retard de la délivrance souvent des rétentions placentaires et de manière systématique une hémorragie du postpartum immédiat donc les facteurs favorisant de l'inertie ce sont les facteurs d'épuisement musculaire ou de mauvaise qualité du myomètre c'est l'épuisement après un travail prolongé, la surdistension utérine, l'infection aussi, la dégénérescence fibreuse du myomètre connu chez la multipart surtout si elle est âgée, diminution de la contractilité de l'utérus qui porte un fibrome ou un utérus mal formé et parfois une cause

médicamenteuse.

Le diagnostic est souvent assez facile par l'existence d'un utérus mal contracté, l'absence du globe utérin de sécurité c'est à dire un utérus qui est mou avec un globe qui dépasse l'embrylique donc mal rétracté et en faisant la révision utérine on retrouve un utérus qui est à tonne, on dit qu'il est vaste à la révision et donc là j'attire l'attention encore une fois sur la possibilité d'association avec d'autres causes. Qu'est-ce qu'on doit faire sur le plan de la prise en charge de l'hémorragie de la délivrance? La prise en charge de l'hémorragie du post partum immédiat répond à un principe fondamental c'est celui de l'escalade thérapeutique, ça veut dire on commence par des moyens simples et au fur et à mesure soit de l'aggravation soit de la non-efficacité on va passer à d'autres éléments. Evidemment on peut parfois court-circuiter certaines étapes si l'hémorragie est grave ou si on a une cause qui nécessite la réalisation d'une ce qu'on appelle un saut d'étapes thérapeutiques.

Donc on va commencer toujours par les moyens médicamenteux oscitocycles pour renforcer la contraction utérine puis les moyens mécaniques et la chirurgie et éventuellement radiologique. Un principe aussi très important dans la prise en charge de l'hémorragie du post partum immédiat c'est que c'est une prise en charge multidisciplinaire c'est-à-dire qui nécessite la coordination entre plusieurs personnes en fonction du niveau de la structure où on est, ça peut être entre le médecin généraliste la sage-femme et l'infirmier anesthésiste comme ça peut être entre l'obstétricien la sage-femme et le médecin anesthésiste en fonction des ressources humaines disponibles dans la structure dans laquelle on travaille. L'essentiel c'est de coordonner les efforts avec tous les intervenants et deuxième principe c'est de considérer l'importance et l'intérêt primordial du temps puisque le temps est très important pour pouvoir gérer ces patients-là et ne pas tomber dans la latence et c'est-à-dire entraîner une hémorragie qui s'aggrave et ne pas mettre une prise en charge appropriée.

Donc il faut toujours noter l'heure initiale du diagnostic parce que le plus souvent le temps s'écoule très rapidement et les pertes sanguines sont le plus souvent sous-estimées par les intervenants donc toujours faire un relevé chronologique des éléments de surveillance et de la prise en charge. Troisième principe de la prise en charge de ces malades avec hémorragie du postpartum immédiat c'est la prise en charge concomitante sur le plan réanimation et obstétrical et recherche étiologique donc en général en parallèle on met en place les éléments de prise en charge de réanimation c'est-à-dire la voie veineuse périphérique, le prélèvement sanguin pour l'énumération et le bilan des mostazes, le remplissage vasculaire, la transfusion ou la préparation à la transfusion. En parallèle l'équipe obstétricale va essayer de rechercher rapidement la cause de ce saignement par les trois gestes qu'on va voir tout à l'heure qui sont systématiques c'est-à-dire la révision utérine, l'examen sous-valve et la recherche du globe de sécurité.

Donc la recherche du globe de sécurité se fait par la palpation, la révision utérine et on fait un examen sous-valve c'est-à-dire des valves vaginales qu'on introduit au niveau du vagin afin

d'examiner le col et le vagin à la recherche de déchirure. Donc en parallèle avec ça on fait aussi une prise en charge obstétricale pour arrêter l'hémorragie en fonction de l'étiologie on va administrer des ocytocines ou faire un traitement chirurgical. Donc prise en charge initiale c'est ce qu'on vient de dire c'est les mesures de réanimation en même temps que la mise en place d'un processus de surveillance de la patiente que ce soit sur le plan hémodynamique mais aussi de l'évaluation du saignement extériorisé à l'aide d'un sac de recueil gradué pour quantifier précisément les saignements.

Donc en parallèle comme on a dit avec ça on va vérifier si la délivrance a été faite on va faire une révision utérine. Si la délivrance n'a pas encore lieu on va faire une délivrance artificielle. La vessie doit être toujours vidée puisqu'elle peut être un facteur limitant la contraction de l'utérus au niveau du segment inférieur.

On va vérifier est-ce que l'utérus est tonique et les sous-ombilicales et on va réaliser l'examen de la filière génitale sous-valve. Donc je rappelle qu'on peut avoir des causes multiples et de ce fait là si par exemple on fait une révision utérine et on trouve une atonie utérine on ne doit pas arrêter la recherche étiologique et on doit obligatoirement faire l'examen sous-valve. Parallèlement il est recommandé d'administrer des utérotoniques de façon systématique puisqu'ils ne sont pratiquement pas contre-indiqués dans aucune des étiologies.

Donc l'ocytocine, la perfusion d'ocytocine est systématiquement démarrée donc on en fait en général 5 à 10 unités par voie intraveineuse lente puis en perfusion pendant deux heures. On peut aussi céder par l'acide tranhexamique qui va augmenter la valeur de la coagulation et de ce fait là diminuer le risque de saignement. Si on réalise un geste endotérin l'antibioprophylaxie est systématique.

Donc ce diagramme montre un petit peu les étapes qu'on vient de faire donc diagnostic de l'hémorragie, délivrance soit effectuée soit non effectuée, mesure de réanimation et les trois gestes ainsi que la perfusion d'ocytocine. Je rappelle toujours des réflexes, les trois gestes systématiques. Voilà la conduite c'est ce qu'on vient de voir afin d'examiner est-ce qu'il y a une étiologie en même temps en parallèle avec la mise en condition, la réanimation et la perfusion d'ocytocine.

Donc si la vacuité utérine est certaine on met l'ocytocine qui va permettre soit d'arrêter l'hémorragie soit cette hémorragie n'est pas arrêtée et donc on continue la prise en charge. Donc suite de ces tableaux et donc là c'est la prise en charge initiale qu'on a vu. Donc je rappelle que réanimation plus recherche d'étiologie plus mesure obstétrique notamment à ce niveau là c'est la perfusion d'ocytocine c'est à dire renforcer la contraction utérine.

Donc durant cette prise en charge initiale en général il faut jamais dépasser 30 minutes de prise en charge si le saignement s'est arrêté c'est bon s'il ne s'est pas arrêté on va considérer que c'est une hémorragie qui s'aggrave ou qui persiste au delà de 30 minutes il faut passer à autre chose

c'est à dire à la deuxième étape. Je rappelle aussi que parfois on peut faire un passage directement vers la deuxième étape si jamais le saignement est déjà très grave. Donc une hémorragie du postpartum immédiat qui s'aggrave c'est toujours prise en charge de réanimation et faire un bilan afin de voir le retentissement et de préparer la transfusion, faire un remplissage vasculaire puis passer à des mesures qui vont être plus efficaces que la perfusion d'ocytocine.

Il s'agit de deux principales méthodes thérapeutiques c'est des médicaments utérotroniques plus puissants que l'ocytocine et notamment c'est le sulprostone qui malheureusement n'est pas encore commercialisé au Maroc et qui je pense ne va pas tarder à être disponible dans les hôpitaux marocains donc c'est une prostaglandine qui a une action puissante et qui s'administre par voie intraveineuse. En général ce médicament on l'utilise après 30 minutes de perfusion d'ocytocine qui est inefficace ou jugée peu efficace et qui va permettre le plus souvent d'améliorer la contraction utérine et d'arrêter le saignement. Deuxième méthode aussi c'est le tamponnement intra-utérin ce qu'on appelle le ballon de Bakri qu'on introduit à l'intérieur et qu'on va gonfler par du sérum et qui va permettre d'arrêter et de comprimer les vaisseaux et d'arrêter le saignement.

Donc c'est une méthode aussi qui est assez efficace et qui là aussi malheureusement n'est pas encore disponible partout dans les hôpitaux mais qu'il faut connaître parce que probablement elle va être disponible incessamment. Donc ça c'est le ballon de Bakri qu'on introduit qu'on gonfle et qui va permettre d'arrêter le saignement. Donc une hémorragie qui s'aggrave et qui persiste au-delà de 30 minutes on passe à la deuxième étape comme on a dit qui comporte les prostaglandines par voie intraveineuse ou le ballon de Bakri ou bien passer aussi à d'autres méthodes de ce qu'on appelle les obstructions vasculaires que ce soit par radiologie ou par chirurgie.

Donc dans notre contexte si on n'a pas ces moyens ou si l'hémorragie est d'emblée grave on va passer directement à l'étape chirurgicale et c'est pratiquement la réalité quotidienne dans les hôpitaux marocains on va passer directement à la chirurgie. Donc avant de parler des techniques chirurgicales et des cas particuliers du placenta accreta je rappelle juste que le misoprostol qui est un analogue synthétique de la prostaglandine E1 est un puissant utérotonique qui peut être administré par voie orale, sublinguale ou rectale et ou vaginale et donc dans notre contexte on l'utilise le plus souvent comme traitement de deuxième intention par voie rectale à raison de 800 microgrammes et qui souvent souvent va permettre d'arrêter l'hémorragie et jouer le rôle du sulprostone, c'est-à-dire du nalador. Le cas particulier du placenta accreta donc il est particulier pourquoi parce que le traitement est souvent chirurgical on ne peut pas réaliser une délivrance et de ce fait là s'il y a une absence de délivrance et on a fait le diagnostic positif d'un placenta accreta il faut surtout ne pas essayer de décoller le placenta par la main c'est à dire par une délivrance artificielle puisqu'on va aggraver les saignements et donc on va juger en fonction de l'état hémodynamique de la patiente.

Si le placenta est en place et il n'y a pas de saignement on peut faire ce qu'on appelle un

traitement conservateur c'est-à-dire clomper le cordon et laisser le placenta en place. S'il y a une hémorragie c'est une indication d'emblée à la chirurgie où on va le plus souvent réaliser une hystérectomie totale afin de pouvoir arrêter l'hémorragie donc le traitement de référence en cas de placenta accreta est essentiellement l'hystérectomie. Donc à part ce cas particulier donc si on a une hémorragie qui persiste malgré l'administration des prostaglandines ou bien qui est grave d'emblée comme on a dit on va passer aux méthodes invasives et qui sont de deux sortes soit radiologiques soit chirurgicales.

Radiologique il s'agit de l'embolisation artérielle où on va faire un catétérisme des artères utérines et on va injecter des particules qui vont obstruer les artères utérines ainsi arrêter l'hémorragie. Les conditions pour pouvoir réaliser ça c'est d'avoir un plateau technique fonctionnel, des radiologues entraînés et troisièmement une patiente avec un état hémodynamique encore stable. S'il y a une instabilité hémodynamique l'embolisation ne peut pas se faire et on passe directement à la chirurgie.

La chirurgie comporte deux volets soit un traitement conservateur c'est à dire on va faire soit une ligature des artères utérines ou iliaques ou bien des techniques de compression de l'utérus ou bien un traitement radical qui est celui de l'hystérectomie. Donc la chirurgie comme on a dit s'intègre dans le principe d'escalade thérapeutique donc c'est l'arme thérapeutique ultime après les premières étapes 1, 2 et 3. Donc il y a des cas où la chirurgie s'impose d'emblée comme le cas par exemple d'une rupture utérine donc il ne s'agit pas du tout d'un cas où on va faire les trois étapes puis passer à la chirurgie donc une rupture utérine relève directement d'un traitement chirurgical par la parotomie avec suture de l'utérus ou bien parfois hystérectomie. Le cas aussi de déchirure cervico-vaginale ou de placenta accreta.

Dans les autres situations la chirurgie elle est un traitement de dernier recours après les méthodes médicales et obstétricales. Donc quelles sont les méthodes comme on a dit il y a une multitude de techniques des mesures spécifiques comme on a dit de réparation directe de déchirure ou bien des méthodes qui sont non spécifiques. C'est soit les méthodes conservatrices on va faire des ligatures ou les techniques de plicature ou les méthodes non conservatrices c'est à dire l'hystérectomie.

Donc les ligatures plusieurs types on peut ligaturer l'artère utérine associée à la ligature des artères utéros ovariennes et aussi du ligament rond ce qu'on appelle la triple ligature qu'on utilise très très très fréquemment. Les ligatures stepwise c'est à dire on va remonter au fur et à mesure sur les branches des artères utérines afin d'arrêter le saignement c'est une méthode qu'on n'utilise pas beaucoup. La ligature des artères épigastriques qui va réduire le flux vasculaire au niveau de la région utérine mais aussi cervico-vaginale et donc c'est une méthode qui est aussi assez efficace.

On peut aussi associer aux méthodes de compression utérine qui peuvent se faire selon plusieurs techniques donc il y a ce que vous voyez à gauche c'est ce qu'on appelle la technique

de Bélinch technique qu'on utilise très très souvent avec une plicature ce qu'on appelle un saucissonnage de l'utérus avec une compression qui va permettre d'arrêter le saignement donc vous voyez l'image en bas et à gauche à droite vous voyez ce qu'on appelle les points de choux on va réaliser des points en carré comme ça et qui vont solidariser la paroi antérieure et la paroi postérieure de l'utérus afin de comprimer les vaisseaux et d'arrêter les saignements. Dans les cas où il y a une hémorragie très grave ou bien ces méthodes ne sont pas efficaces on a recours directement à une hystérectomie qui est le traitement ultime et qui malheureusement reste nécessaire dans un certain nombre de cas. Donc ici des algorithmes de prise en charge après un accouchement par voie basse ou par césarienne et donc ça rappelle juste les éléments qu'on a dit dans ce cours là.

(1:07:33 - 1:13:02)

Donc avant de terminer il est très important d'insister sur un élément capital qui est celui de la prévention de l'hémorragie du postpartum et donc l'intérêt déjà de cette prévention vient du fait que l'hémorragie du postpartum immédiat est la première cause de mortalité maternelle et qu'il y a une possibilité d'action avec des moyens simples et peu coûteux afin de réduire le risque alors qu'on sait que parfois lorsque l'hémorragie elle est là où elle est négligée on va avoir recours à des moyens de prise en charge très très importants, agressifs, invasifs, coûteux avec parfois des résultats qui ne sont pas satisfaisants, des patients pour lesquels qui sont reçus après un retard important peuvent subir des hystérectomies, des transfusions massives, des mesures de réanimation alors qu'ils peuvent avoir des complications voire même un décès malgré tous ces moyens là. D'où l'intérêt de prévenir et de traiter très précocement et ceci a été montré par l'expérience des pays développés où la fréquence d'hémorragie est très diminuée par la médicalisation de l'accouchement. Donc cette prévention doit commencer d'abord par l'évaluation des facteurs de risque afin d'adresser ces mesures aux patientes à risque si c'est possible bien sûr.

Donc les femmes à risque ce sont les multiparts, les patientes avec prééclampsie, avec grossesse géménaire, hydramnios, travail prolongé enfin tous les facteurs de risque qu'on a vu tout à l'heure mais malheureusement lorsqu'on étudie cliniquement les hémorragies du postpartum 90% des femmes qui vont avoir une hémorragie n'ont pas de facteur de risque et de ce fait là les mesures préventives doivent être conduites chez toutes les parties orientantes. Toute femme qui rentre à la salle d'accouchement par accouché doit être considérée comme à risque d'avoir une hémorragie et on doit faire attention pour prévenir. Donc comment prévenir c'est au cours de la grossesse déjà supplémenter en fer afin de réduire le risque d'anémie qui est un facteur aggravant de l'hémorragie.

Au cours du travail il faut médicaliser le travail et le suivre afin d'éviter les dystocies et le travail prolongé qui va épuiser le musculotérin et entraîner une inertie parfois réfractaire. Après l'accouchement et c'est fondamental il faut surveiller les patientes immédiatement après

l'accouchement durant au moins deux heures afin de dépister les hémorragies débutantes et de pouvoir les traiter. On parle aussi d'une prise en charge active de la délivrance c'est à dire c'est essentiellement la délivrance dirigée par l'administration de 5 à 10 unités de cytotocine par voie intraveineuse immédiatement après l'expulsion fatale afin de réduire le risque d'hémorragie.

Donc ça c'est la prévention primaire, la prévention secondaire, c'est la prise en charge appropriée, rapide et bien organisée dès le diagnostic de l'hémorragie du postpartum immédiat et la prévention tertiaire, c'est la prise en charge des complications par la réanimation. Donc la prise en charge active de la troisième phase du travail c'est ce qu'on appelle la délivrance dirigée et donc qui va consister à administrer le cytotocine mais aussi à réaliser un petit massage du fond utérin en même temps qu'une traction contrôlée du cordon c'est à dire une traction douce et continue afin d'accélérer le processus de délivrance et de décollement sans pour autant entraîner des déchirements au niveau du placenta ou des membranes augmentant ainsi le risque de rétention placentaire. Surtout surtout ne pas oublier la surveillance stricte en salle de travail pour une durée minimum de deux heures.

Donc enfin la connaissance parfaite de la physiologie des mécanismes de la délivrance nous permet de respecter la physiologie. La surveillance doit être stricte dans les deux heures au moins mais surtout dans les 24 heures suivant l'accouchement afin de dépister les complications de la délivrance et de pouvoir les traiter. L'hémorragie est grave, mortelle et fréquente donc attention attention attention et le succès thérapeutique dépend de la précocité mais aussi de la coordination entre les différents intervenants notamment l'équipe de réanimation obstétrique ou bien dans les centres de santé l'équipe de massage femme l'infirmière anesthésiste gérée par le médecin généraliste qui doit jouer le rôle du chef d'orchestre de la prise en charge et d'organiser la prise en charge par paliers qui doivent être parfaitement connus par toute l'équipe obstétrique.

Je vous remercie